

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小兒存留導尿技術				
	Retention of Catheterization for Child				
編號	A31000-Q05-W-D11	制定者	IR 黃淑媛	公布日期	96 年 07 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.8 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能依據 CAUTI Bundle 及洗手五時機，操作小兒存留導尿技術。

二、範圍

兒科各單位。

三、說明

（一）技術目的

- 1.協助自解困難的病人將膀胱的尿液排出，以防止尿道感染。
- 2.避免會陰部、肛門等部位手術後的傷口感染。
- 3.判斷及監測尿液排出情形。
- 4.採取無菌的尿液標本。

（二）用物準備

- 1.拋棄式導尿包：包裝包布 80×80 cm、不附背膠洞巾 60×60 cm、大棉棒 6 支、醫用紗布 10×10 cm、消毒液盒、潤滑劑 3ml。
- 2.無菌消毒溶液：優碘溶液或 Aqua 2%CHG 水溶液。
- 3.無菌手套 1 雙（尺寸視需要）。
- 4.存留導尿管（尺寸視需要）或用 5Fr、8Fr、10Fr.的鼻胃管代替。
- 5.蓄尿袋一只或精密尿筒一個。
- 6.10 c.c.無菌空針一支。
- 7.無菌蒸餾水溶液。
- 8.固定膠布、紙膠、Tegaderm 或 mefix。

主題名稱	小兒存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D11	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/8

9.無菌尿盒（視需要）。

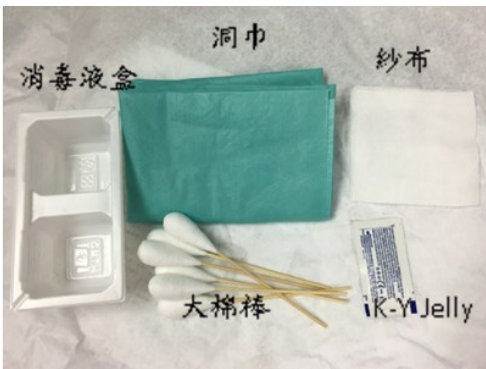
（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1.核對醫囑及病人： 核對電腦 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行醫囑於核對狀態核簽“正確”，並確認小兒存留導尿同意書是否簽署完整。	
(1)正確使用兩種以上辨識方法辨識病人，向病人或家屬解釋（說明目的及步驟）。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
(2)工作前洗手。	
(3)準備用物，選擇適合病童的導尿管。	檢視拋棄式導尿包的外包裝是否完整？有效日期是否過期？ 導尿管尺寸： (1)嬰兒：3Fr.的導尿管（或 5Fr.的鼻胃管代替）。 (2)兒童：8~10Fr.。 (3)青少年：12~14Fr.。
(4)攜帶用物至病童單位。	
(5)辨識病人（至少二種以上方法）。	辨識方法請依照「A31000-Q02-W-A09 病人辨識作業作業標準」執行。（若為新生兒請核對腳圈登記之資料）
(6)準備病童： 6-1 時機 1 接觸病人前洗手 A. 拉上圍簾。 B. 搖平床頭，協助病童平躺並脫去褲子。	導尿姿勢： (1)女病童：採屈膝仰臥的姿勢。 (2)男病童：採仰臥的姿勢。
(7)準備會陰沖洗及存留導尿用物： 會陰沖洗 A. 沖洗壺（生理沖洗器） B. 沖洗棉枝1-2包。 C. 41-43℃煮開的溫開水。 D. 看護墊或便盆及橡皮中單。 ※女病童： 1. 將煮沸開水調和41-43℃溫度，倒入沖洗壺。 2. 協助病童採屈膝仰臥姿勢。 3. 用被子覆蓋病童脫除衣褲露出外陰部。 4. 以防護墊（布中單）墊於病童臀下，放置便盆或直接墊看護墊。	請參閱A31000-Q05-W-C08會陰沖洗 ※男病童：（專科護理師或醫師執行為主） 1. 將病人的包皮撥開露出龜頭，一手固定陰莖，另一手拿沖洗壺，再以慣用手拿濕棉枝，由上而下擦拭一圈，清洗乾淨後取一乾棉枝擦乾，將包皮推回。 2. 清洗陰莖及陰囊，撥開陰囊清洗兩側鼠蹊部

主題名稱	小兒存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D11	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
5. 打開沖洗棉枝，置於手上。 6. 手持沖洗壺及棉枝，沖洗壺口朝向床尾，先沖少許溫水於病童的大腿內側，測試水溫，將溫水緩緩沖洗，並詢問水溫是否合宜。 7. 以棉枝擦洗陰道口、陰唇、外陰部。（由內而外順序清潔陰部，每一支棉枝必須由上而下清洗擦拭，不可上下來回重複使用，若棉枝碰觸到肛門時不可再用。） 8. 清潔後，再以棉枝擦乾陰部。	至肛門口。 3. 沖洗乾淨後以棉枝輕輕擦乾，或以衛生紙、毛巾輕拍吸乾水份。 4. 移除便盆或尿布。
2. 操作過程 (1)時機 3 暴露病人體液風險後 & 時機 2 執行無菌技術前洗手 (2)以無菌技術打開拋棄式導尿包。	確實執行無菌技術，如有任何污染的狀況應立即更換導尿包。 
(3)請病童抬高臀部，將拋棄式導尿包的包布，墊在病童的臀下。	
(4)拆開導尿管外包裝紙後以無菌原則置於包布無菌區內。	視需要使用無菌鑷子。
(5)10c.c.空針拆開外包裝紙，以無菌原則置於包裝包布無菌區內。	
(6)拆除蓄尿袋包裝紙，以無菌原則置於包裝包布無菌區內。	
(7)遵循無菌原則分別將優碘溶液及蒸餾水溶液分別倒於雙格消毒液盒中。	若是 20cc 瓶裝蒸餾水(D/W)溶液瓶口先使用酒精棉片消毒過後再打開。

主題名稱	小兒存留導尿技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-D11	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
	
(8)以無菌技術戴上無菌手套。	
(9)以 10c.c.空針從消毒液盒中抽取固定用之蒸餾水。	
(10)將導尿管由內包裝取出接上蓄尿袋或精密尿筒的接口。	
(11)以沾有潤滑劑的無菌紗布，潤滑導尿管前端 2~4 吋（約 5~10 公分）。	
(12)將無菌洞巾鋪於病童會陰部： A. 兩手各持洞巾的一個頂角。 B. 將兩側頂角稍向內翻。 C. 將洞巾缺口對準病童的尿道口鋪下。	以防雙手碰觸病童雙腿而污染手套。
(13)露出尿道口，並以一手固定此位置，直至插入導尿管為止。 A. 女病童的固定方法：一手的食指和大拇指分開小陰唇。 B. 男病童的固定方法：一手握住陰莖，將包皮往後推。	充足的光線，可更清楚找到尿道口，此時手指已屬污染，不可任意移動位置。
(14)另一手拿優碘棉棒消毒尿道口，優碘消毒時間需停留 2 分鐘，使用過的棉棒丟入垃圾袋或彎盆中。 A. 女病童的消毒法： (A) 第一支棉棒由上往下擦拭遠側小陰唇。 (B) 第二支棉棒由上往下擦拭近側小陰唇。 (C) 第三支棉棒由上往下擦拭尿道口 B. 男病童的消毒法：由尿道口起，以環形方式擦拭。	一支棉棒僅能使用一次，勿來回擦拭。
(15)再用蒸餾水棉棒，依上述的方式消毒。	在優碘棉棒之後擦拭蒸餾水棉棒，以洗淨皮膚上

主題名稱	小兒存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D11	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/8

步驟	說明
	的優碘，避免優碘對皮膚造成刺激。
(16)將治療碗或彎盆靠近病童會陰部，將導尿管的末端置於治療碗或彎盆內。	1.避免導尿管插入膀胱時，尿液流出弄髒床單。 2.若需留取無菌尿液標本，則留取中段尿液 6~10 c.c.於無菌容器內。
(17)請病童張口哈氣或做深呼吸，將導尿管插入尿道口。 A. 女病童：插入 1~2 吋 (2.5~公分)，或尿液流出為準則。 B. 男病童：將陰莖豎立成 90 度，插入 2~3 吋 (5~5.7 公分)，或尿液流出為準則。	
(18)當尿液流出時，可用手輕揉地按壓膀胱。	有助於膀胱的排空。
(19)確定留置導尿管已可適當地引流尿液時，則打入 5~10 c.c.蒸餾水至導尿管的氣囊內。	1.不可過度膨脹氣囊，以免尿道口受刺激而有疼痛感。 2.以鼻胃管代替尿管不須此過程。
(20)輕拉回導尿管，確定導尿管已固定，(不可回推)	以鼻胃管代替尿管不須此過程。
(21)捏住導尿管並移開洞巾。	
(22)將導尿包及用物丟至感染性垃圾桶。	
(23)脫除手套，進行時機 3 暴露病人體液風險後洗手。	
(24)以膠布、紙膠、Tegaderm 或 mefix 固定導尿管於病童大腿內側，嬰兒則以 Tegaderm 固定於會陰，再以紙膠固定於大腿內側上 1/3 或下腹部或大腿前側。 A.女病童：大腿內側上 1/3。 B.男病童：下腹部或大腿前側。	固定時，須注意尿道口與大腿間應留有足夠的長度，以免移動時扯到導尿管。
(25)固定蓄尿袋或精密尿筒於床緣，並在蓄尿袋或精密尿筒上註明日期。	1.蓄尿袋或精密尿筒每星期須更換一次，故應註明更換日期。 2.導尿管更換期限一星期一次、矽質(silicon)材質導尿管一個月更換；導尿管如有，阻塞、滲透、髒汙或感染等情形或尿袋破損皆須應立即更換，且導尿管及尿袋應一起更換。 2.蓄尿袋高度不可高於膀胱，也不可接觸地面。 3.隨時檢查引流系統是否受壓迫或曲摺，並評估病人有無不適之主訴（如：疼痛、發燒）及蓄尿袋內或精密尿筒尿液之性質（如：尿量減少、

主題名稱	小兒存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D11	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/8

步驟	說明
	顏色混濁或呈血色、惡臭)。
3. 操作後護理	
(1) 移去洞巾及用物。	
(2) 清潔外陰部，協助病童穿好衣褲，整理病童單位。	
(3) 清理用物。	
(4) 離開病房後，進行時機 4 接觸病人後洗手。	
(5) 記錄。	記錄內容：時間、導出量、尿液顏色、性質及病人反應等，於護理系統/「管路管理」登錄置入及移除日期。

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 李淑杏、陳迺荭、王淑芬、張淑文、黎小娟、周利娜、陳家盈、謝玉惠合著(2011)。

貼集尿袋（收集無菌尿液標本），產兒科護理技術（272-276 頁）。台北：華杏。

(二) 蘇麗智、簡淑真、劉波兒、蘇惠珍、林靜娟等合著(2011)。單次導尿法（間歇導尿

法），實用基本護理學（385-392 頁）。台北：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	小兒存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D11	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
96.07.31	1.0	新制定。	96 年 07 月 31 日 護理部技術標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.12.14	2.1	修改錯別字。	100 年 12 月 14 日 護理部技術標準 委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.12.15	3.1	1. 第三項說明內容 HIS2008 統稱為 HIS 系統。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 12 月 15 日 護理部技術標準 委員會通過。
105.12.20	3.2	1. 第三項第(二)、(三)目內容，將導尿包改為一次性(拋棄式)導尿包。 2. 修正第三項第(三)目之 1(2)病人辨識說明。	105 年 12 月 20 日 護理部技術標準 委員會通過。
106.12.18	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.12.16	3.3	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 09 日 護理技術組會議 通過;108 年 12 月 11 日護理長會議 通過;108 年 12 月 16 日督導會議通 過公布。
110.01.19	3.4	1. 新增第三項第一目之 3 說明。 2. 第三項第二目用物準備內容修訂。 3. 第三項第三目步驟及要點說明內容修訂。 4. 第三項第三目之 2(15)刪除再回推倒尿管 2 公分，新增(不可回推)。	109 年 12 月 14 日 護理技術組會議 通過;110 年 01 月 13 日護理長會議 通過;110 年 01 月

主題名稱	小兒存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D11	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
			19 日督導會議通過公布。
111.03.08	3.5	第三項第三目步驟及要點說明之 1、核對醫囑及同意書是否簽署完整。	110 年 12 月 13 日護理技術組會議通過;110 年 01 月 12 日護理長會議通過;111 年 03 月 08 日督導會議通過公布。
112.03.07	3.6	第三項第三目步驟及要點說明內容修訂。	111 年 12 月 19 日護理技術組會議通過;112 年 02 月 08 日護理長會議通過;112 年 03 月 07 日督導會議通過公布。
113.01.23	3.7	1. 修正第三項第二目用物準備之消毒溶液。 2. 修正第三項第三目步驟及要點說明 2.(3)之消毒溶液。	112 年 12 月 19 日護理技術組會議通過;113 年 01 月 10 日護理長會議通過;113 年 01 月 23 日督導會議通過公布。
113.12.16	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.8	1.主題名稱「法」改為「技術」 2.第一項增加：CAUTI Bundle 及洗手五時機 3.第三項第二目第 2 點增加：Aqua 2%CHG 水溶液 4.第三項第三目內容依 bundle 加入洗手五時機內容修訂	114 年 12 月 15 日護理技術組會議通過;115 年 03 月 18 日護理長會議通過;115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。